

Insuficiência cardíaca · congestão e perfusão

Na IC aguda descompensada, classifique congestão (úmido/seco) e perfusão (quente/frio). A conduta de prova segue o perfil hemodinâmico, não só a FE.

Sinais de congestão e hipoperfusão

Lembre - Sinais de congestão e hipoperfusão

Congestão: ortopneia, crepitações, edemas, turgência jugular, B3. Hipoperfusão: extremidades frias, oligúria, confusão, lactato! , PAM baixa ou pulso fino.

Úmido-quente é o mais comum; úmido-frio exige vasoativo/inotropo e cuidado com hipotensão.

Perfis de IC aguda

Congestao x perfusao (Forrester clinico)

Umido-quente

Congestao + perfusao OK
Diuretico +/- vasodilatador
O2 / VNI se EAP

Perfil mais frequente

Umido-frio

Congestao + hipoperfusao
Inotropo / vasopressor
UTI / suporte avançado

Choque cardiogenico

Seco-frio

Baixo debito sem edema
Volume prudente se hipovolemico
Inotropo se persistir

Menos comum

Conduta inicial

- ABC, O₂ / VNI (CPAP/BiPAP) no EAP hipertensivo se sem contraindicação
- Diurético de alça EV na congestão (furosemida); monitorar diurese e K⁺
- Vasodilatador (nitrato) se PA elevada e congestão — evitar se hipotenso
- Troponina, ECG, Rx tórax, BNP/NT-proBNP e etiologia precipitante (IAM, infecção, FA, falha de adesão)

Drogas por cenário

Cenário | Preferência de prova

EAP + HAS | VNI + nitrato + diurético

Congestão, PA estável | Diurético ± vasodilatador

Choque cardiogênico | Noradrenalina ± dobutamina; UTI

IC crônica estável (alta) | IECA/BRA/ARNI + beta-bloqueador + antialdosterônico + iSGLT2

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Não inicie ou aumente beta-bloqueador na descompensação com congestão/hipoperfusão franca. Mantenha dose se já em uso e estável; suspenda se choque ou BAV grave.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1